

Profilaktyka *nawrotów*

Pierwsze 90 dni abstynencji to dopiero początek. Następne 12 miesięcy decyduje o trwałości. CBT-RP to plan na sześć filarów ochrony.

CZAS: 60 min na opracowanie planu Po 30+ dniach abstynencji

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985, RP); Witkiewitz & Marlatt (2004)

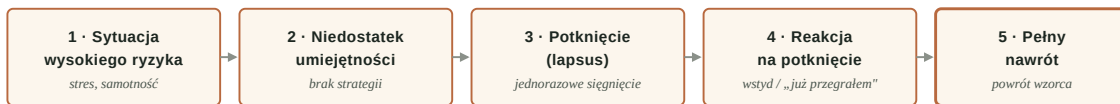
JAK UŻYWAĆ

Profilaktyka nawrotów (ang. *relapse prevention, RP*) — model Marlatta i Gordona, zaadaptowany do PPU. Pokazuje, że **nawrót nie jest nagły** — to proces budujący się tygodniami. Pacjent uczy się rozpoznawać **łańcuch nawrotu**: sytuacja wysokiego ryzyka → niedostatek umiejętności radzenia → potknięcie (lapsus) → reakcja na potknięcie → pełny nawrót. Karta przedstawia **6 filarów ochrony**: lista sytuacji ryzyka, plan kryzysowy, sieć wsparcia, codzienna higiena, monitorowanie warning signs, plan po potknięciu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt & Gordon (1985) wykazali, że **70% nawrotów** w terapii uzależnień następuje w **pierwszych 90 dniach**, ale kolejne 30% następuje w miesiącach 4–12. Stąd profilaktyka nawrotów nie kończy się po 90 dniach. Witkiewitz & Marlatt (2004): pacjenci z pisemnym planem RP mają **40–60% niższe ryzyko nawrotu** w 12 mies. niż pacjenci bez planu. W PPU specyfika: porno jest **dostępne natychmiast** (1 klik), wyzwalacze są wszechobecne (reklamy, telefon), abstynencja jest trudna do zdefiniowania (seksualność nie znika). Stąd RP w PPU musi być **dokładnie szyte na miarę** — generyczne plany nie wystarczają.

01 📋 Łańcuch nawrotu — pięć etapów



RP przerywa łańcuch w etapie 2 (uczy umiejętności) lub 4 (zmienia reakcję na potknięcie)

02 🎯 Sześć filarów ochrony

1 · LISTA SYTUACJI WYSOKIEGO RYZYKA

Twe 5–10 najczęstszych wyzwalaczy: emocje, miejsca, pory, konteksty. Świadomość = pierwsza linia obrony.

2 · PLAN KRYZYSOWY

Gdy SUDS przekroczy 70 — co dokładnie robię. 3–4 konkretne kroki. Spisane, nie wymyślone na chwilę.

3 · SIEĆ WSPARCIA

2–3 osoby, które wiedzą o problemie i mogą pomóc w kryzysie. Telefony zapisane, dostępne. Grupa wsparcia.

4 · CODZIENNA HIGIENA

Sen 7–8 h, ruch 30 min × 3 tyg., regularne posiłki, redukcja stresu, niska podatność = niższe ryzyko.

5 · MONITOROWANIE WARNING SIGNS

3–7 dni przed nawrotem są zwykle sygnały: izolacja, gorszy sen, fantazje. Codzienna 1-minutowa autorefleksja.

6 · PLAN PO POTKNIĘCIU

Najważniejszy. Jeśli się zdarzy: bez wstydu, bez „już wszystko stracone”. Konkretny plan powrotu.

03 Twój plan RP

FILAR 1 · MOJE 5 SYTUACJI WYSOKIEGO RYZYKA

— najsilniejsze wyzwalacze

FILAR 2 · PLAN KRYZYSOWY

— 3 kroki przy SUDS > 70

FILAR 3 · MOJA SIEĆ — 3 OSOBY + TELEFONY

— do kogo dzwonię w kryzysie

FILAR 4 · MOJA CODZIENNA HIGIENA

— sen, ruch, jedzenie

FILAR 5 · MOJE WARNING SIGNS

— co zauważam 3–7 dni przed

FILAR 6 · MÓJ PLAN PO POTKNIĘCIU

— 3 konkretne kroki powrotu, bez wstydu

Klucz: Witkiewicz & Marlatt (2004) w metaanalizie 26 badań RP wykazali, że **kluczowy moment** profilaktyki nawrotów to *reakcja na potknięcie* (etap 4). Tu decyduje się, czy lapsus stanie się pełnym nawrotem. Pacjenci, którzy interpretują potknięcie jako „jedno wydarzenie, z którego się uczę” — wracają do abstynencji w 60–70% przypadków. Pacjenci, którzy interpretują jako „znowu wszystko zepsułem, koniec” (efekt AVE — *abstinence violation effect*) — wracają tylko w 20–30%. Dlatego filar 6 (plan po potknięciu) jest często ważniejszy niż filary 1–5 razem. Spisz go *przed*, kiedy jesteś spokojny/-a. W kryzysie mózg nie wymyśla — wykonuje plan.